CENTRE HOSPITALIER FICTIF DE L'ESTEY

Centre d'évaluation et de traitement de la douleur (CETD)

Responsable
Dr Gaëtan PUYOOU
Médecins
Dr Sixtine OLHAGARAY
Dr Florent BERDOULAT
Psychologue
Mme Fanette CAUBARRÈRE
Infirmière ressource douleur
Mme Rolande LAULHÉ
Secrétariat
Tél. 05 00 47 19 62

Bordeaux, le 22/02/2021

Dr Ombeline ARRIBEHAUTE
CSAPA - Pôle d'addictologie
CH fictif de l'Estey

Objet : récapitulatif de la prise en charge douloureuse
Patient : M. HONTABAT Raymond, né le 12/02/1961

Chère Consœur,

Suite à votre demande du 17/11/2020, voici le récapitulatif de la prise en charge de M. HONTABAT dans notre centre, que nous suivons depuis le 03/04/2014.

Accident du travail le 14/10/2013 : chute d'un échafaudage d'une hauteur d'environ 4 mètres, fracture-tassement de L1 avec recul du mur postérieur. Arthrodèse T12-L2 le 16/10/2013 au CHU. Reprise chirurgicale le 09/06/2015 (pseudarthrose, extension de l'arthrodèse à L3). Consolidation fixée au 31/03/2016, mise en invalidité dans la foulée. Lombalgies chroniques et radiculalgie L5 droite, avec composante neuropathique (DN4 à 5/10).

Antécédents relevés à la première consultation (2014) : HTA ; tabagisme actif ; trouble de l'usage de l'alcool avec sevrage hospitalier de 3 semaines en mars 1999 (clinique des Pins, Lormont), abstinence déclarée depuis.

Traitements antalgiques :
- tramadol d'octobre 2013 à juin 2015, jusqu'à 400 mg/j ;
- oxycodone à partir de juin 2015, 40 mg/j, augmentée jusqu'à 120 mg/j fin 2016 ;
- fentanyl transdermique de février 2017 à octobre 2018 (25 puis 50 et 75 µg/h), avec oxycodone à libération immédiate en interdoses, arrêté devant une efficacité jugée insuffisante par le patient ; retour à l'oxycodone LP 120 mg/j en novembre 2018 ;
- prégabaline introduite en mars 2016 à 75 mg x 2, portée à 150 mg x 2 en 2017 ;
- alprazolam prescrit par le médecin traitant.

Nous avions relevé à plusieurs reprises en 2017-2018 des demandes de renouvellement anticipé, sans en connaître l'ampleur. Les doses supérieures à 120 mg/j d'oxycodone n'ont jamais été prescrites par notre centre.

Rééducation et TENS proposés à plusieurs reprises, peu suivis. Le groupe « douleur et mouvement » lui a de nouveau été proposé.

Nous sommes favorables à la poursuite de la méthadone, sans réintroduction d'un autre opioïde antalgique, et restons à votre disposition pour une réévaluation.

Je vous prie de croire, Chère Consœur, à l'expression de mes sentiments confraternels.

Dr Gaëtan PUYOOU